

MAREOS Y VÉRTIGO

Elvira Solanas Letosa, Óscar Durán Borrella, Rebeca de la Fuente Blanco.

INTRODUCCIÓN

El mareo y el vértigo constituyen uno de los motivos de consulta habituales en el Servicio de Urgencias. La historia clínica es el elemento clave para su correcto diagnóstico, junto con una exploración neurootológica adecuada.

Es fundamental delimitar el tipo de mareo que padece el paciente. Dentro de este término se engloban cuatro posibilidades: presíncope o síncope, desequilibrio, vértigo y mareo psicofisiológico. Por definición todo paciente con vértigo debe padecer ilusión de movimiento, es decir, ver como se desplaza él o el entorno. No se considera vértigo a sensaciones como “flotar” o inestabilidad. Una vez diagnosticado el vértigo, debemos conocer la frecuencia de los ataques, la duración y si se desencadenan con alguna maniobra. Con estos datos podemos dividir el vértigo en: a) vértigo episódico o esporádico, b) vértigo recurrente no posicional; y c) vértigo recurrente posicional.

También es importante conocer la presencia de otros signos y síntomas acompañantes como acúfenos, hipoacusia, alteraciones autonómicas, cefalea o síntomas focales neurológicos.

DIAGNÓSTICO

Vértigo episódico

Es aquél que ocurre una sola vez. El vértigo prolongado de instauración aguda se debe a una pérdida de la función vestibular, generalmente unilateral. La historia clínica y exploración debe dirigirse para diferenciar si se trata de un vértigo central o periférico.

Vértigo Periférico

- **Neuritis o neurolaberintitis vestibular:** Síndrome vestibular periférico (vértigo, náuseas y vómitos) de instauración progresiva con un máximo generalmente a las 24 horas y lenta mejoría.
- **Infecciones bacterianas del oído interno y del hueso temporal:** Infecciones en el oído externo no suelen acompañarse de clínica vertiginosa y las del oído medio sólo de manera ocasional. La afectación de oído interno dará una clínica de vértigo periférico.
- **Vértigo postraumático agudo:** Ocurre inmediatamente tras el trauma craneal, consecuencia de la hipofunción vestibular unilateral.

Vértigo Central

- **Ictus vertebrobasilar e isquemia vestibular:** La vascularización del oído interno, el tronco y cerebelo, depende del sistema vertebrobasilar. En caso de isquemia de la arteria auditiva interna, los síntomas pueden confundirse con un vértigo periférico, pero la presencia de cofosis continua y, habitualmente, de otra focalidad neurológica, nos orienta a un origen central. Infartos en otros territorios del sistema vertebrobasilar, como el ictus bulbar posterolateral o Síndrome de Wallenberg, también pueden manifestarse como vértigo central en compañía de otros síntomas (diplopía, disfagia, disartria, hemihipoestesia, síndrome de Horner...)
- **Lesiones desmielinizantes y tumores:** Aquellas localizadas en fosa posterior también pueden manifestarse en forma de vértigo central.

	Vértigo periférico	Vértigo central
Cortejo vegetativo	Intenso	Leve- moderado
Hipoacusia/acúfenos	Frecuentes	Raros
Osciloscopia	Leve	Intensa
Pérdida de equilibrio	Leve, salvo al inicio. Es capaz de caminar, aunque suele tender a caer hacia el lado afecto	Grave Es incapaz de mantenerse en pie o caminar
Nistagmus	Horizonto-rotatorio u horizontal Unidireccional y agotable Máximo en la dirección de la fase rápida Disminuye con la fijación visual	Vertical o torsional puro Dirección cambiante Persistente No se modifica con la fijación
Impulso cefálico	Positivo	Negativo
Focalidad neurológica	Ausente	Presente (no siempre)

Vértigo recurrente no posicional

- **Enfermedad de Ménière:** Sensación de presión en el oído, hipoacusia, acúfenos y episodios vertiginosos de 30 minutos a 2 horas de evolución y que pueden repetirse varias veces al día. Posteriormente puede haber sensación de inestabilidad durante días.
- • **Enfermedad autoinmune del oído interno:** Cuadro rápidamente progresivo de inicio unilateral, que termina afectando a ambos oídos. Se manifiesta por hipoacusia, sensación de presión en el oído, acúfenos e hipofunción vestibular. Puede ser debido a cuadros sistémicos (LES, AR), formar parte del síndrome de Cogan o ser una afectación primaria del oído interno.
- • **Vestibulopatía luética:** En la sífilis precoz se manifiesta como hipoacusia bilateral, mientras que en la tardía o congénita el cuadro puede ser unilateral y similar a la enfermedad de Ménière.
- **Vértigo asociado a migraña:** Los pacientes migrañosos pueden presentar cuadros vertiginosos que aparecen con o sin cefalea.
- • **Migraña basilar:** Migraña con aura basilar que precede a la cefalea, en forma de síndrome vertiginoso y otros síntomas neurológicos.

Vértigo recurrente posicional

- **Vértigo posicional paroxístico benigno:** Causa más frecuente de vértigo. Sensación de giro de objetos de inicio brusco que aparece por cambios en la postura cefálica. Se puede acompañar de náuseas y vómitos. Las crisis son limitadas y recurrentes, de segundos de duración, pudiendo reaparecer durante semanas o meses. Se debe a la existencia de otolitos en el canal semicircular, habitualmente en el posterior. El diagnóstico se establece mediante la maniobra de Dix-Hallpike.
- • **Causas centrales:** Tumores de la fosa posterior, lesiones desmielinizantes, migraña, malformación de Arnold Chiari, etc.
- • **Paroxismia vestibular:** Episodios de vértigo de segundos de duración que pueden ocurrir en reposo o con cambios posturales. Se debe a compresión neurovascular del VIII par craneal.
- • **Descompresión del canal semicircular superior:** vértigo que aparece tras la realización de maniobras de Valsalva por aumento de la PIC. Pueden manifestar hipoacusia, autofonía y presión en el oído.
- • **Fístula perilinfática:** Ocurre tras un TCE. Se desencadena tras sonidos intensos. Signo del trago positivo.

TRATAMIENTO

- Tratamiento sintomático del vértigo periférico (neuritis, VPPB):
 - Sedantes vestibulares: Sulpirida 50-100 mg/12h (i.m o i.v) o 50 mg/8 h (v.o), Tietilperazina 6.5mg/8-12h (v.r).
 - Antihistamínicos: Dimenhidrinato 50-100mg/8-12h(v.o, v.r).
 - Benzodiazepinas: Diazepam 5-10mg/8-12h (v.o) o ½ ampolla de 10mg/8h (i.m).
- Antieméticos: Metoclopramida 10mg/8h (v.o, i.m, i.v)
- Tratamiento entre crisis: Betahistina 8-16 mg/8h
- Tratamientos específicos:
 - VPPB: maniobra liberadora de Epley y los ejercicios de Brandt-Daroff.
 - Ménière: Entre crisis, dieta restrictiva en sal, Betahistina, Hidroclorotiazida o Acetazolamida.
 - Laberintitis: Puede requerir antibioterapia.

Nota: Los fármacos que se emplean durante las crisis vertiginosas deben retirarse progresivamente y administrarse no más de una semana, ya que pueden retrasar los mecanismos de autocompensación de las vías vestibulares.

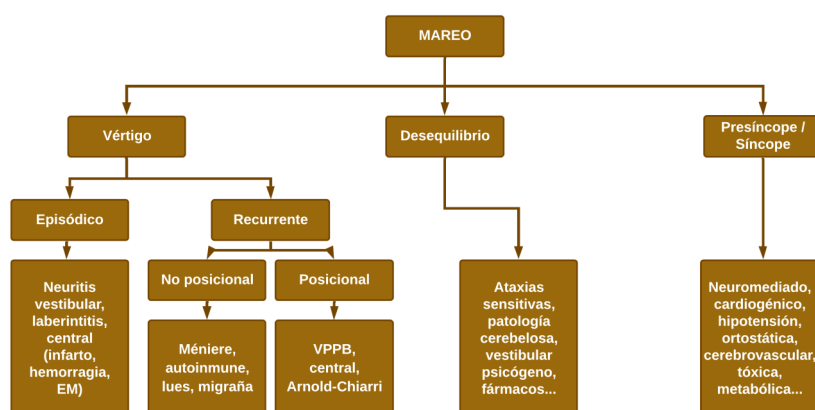
Nota: Como norma general, los pacientes con vértigo de origen central precisarán hospitalización.

Otros tipos de mareo

Cuando el mareo se asocia a desequilibrio o inestabilidad, sin acompañarse de sensación de movimiento ni pérdida de conciencia, hay que pensar en patologías que afecten al SNC (lesiones cerebelosas, subcorticales o de los ganglios basales), alteraciones de la sensibilidad profunda, hipofunción vestibular, causas psicógenas o efectos secundarios de algún fármaco (hipotensores, sedantes vestibulares).

En el presíncope y el síncope, además de sensación inminente de pérdida de conciencia, los pacientes notan visión borrosa, flojedad y malestar general. Las causas son múltiples: de perfil neuromediado, hipotensión ortostática, patología cardíaca, trastornos sistémicos tóxicos y metabólicos, patología neurológica o psicógena.

Otro tipo de mareo es el de perfil psicofisiológico en el que aparece sensación “de cabeza hueca” y “de flotar”, inseguridad al andar sin signos de desequilibrio y empeora con la hiperventilación.



BIBLIOGRAFÍA

- J. Porta Etessam, A. Villarejo Galende. Mareo y vértigo. En: A. Camacho Salas, J. Gonzalez

de la Aleja Tejera J, J.M Sepúlveda Sánchez. Urgencias en Neurología Hospital Universitario 12 de Octubre. 2ª Edición. Madrid: Ergon; 2013. 126-135.

- J.M Olivé, JJ Zarranz. Mareo y vértigo. Sordera y acúfenos. En: J.J Zarranz. Neurología. 5ª Edición. Barcelona: Elsevier; 2013. 93-103
- Bahloh RW, Halmagy GM. Disorders of the vestibular system. Oxford; 1996